

09 - 09- Insuffisance Respiratoire Aigue IRA - Pr. Bouchentouf

Bonjour chers étudiants, le cours d'aujourd'hui c'est l'insuffisance respiratoire aiguë. Les objectifs pédagogiques du cours, tout d'abord définir l'insuffisance respiratoire aiguë, décrire les mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance respiratoire aiguë, reconnaître les signes cliniques de l'insuffisance respiratoire aiguë, préciser ces signes de gravité, énumérer ses principales étiologies et préciser les principes du traitement de l'insuffisance respiratoire aiguë. Le plan du cours comporte une introduction, des rappels physiopathologiques, diagnostics positifs et de gravité de l'insuffisance respiratoire aiguë, diagnostics étiologiques et principales étiologies, puis traitement de l'insuffisance respiratoire aiguë avant de conclure.

L'insuffisance respiratoire aiguë est définie par la survenue brutale d'une défaillance du système assurant les échanges gazeux et se traduit par une baisse soudaine du taux d'oxygène de leçon artérielle, par une pression partielle d'oxygène inférieure à 60 mmHg, avec ou sans hypercapnée. L'hypercapnée est définie par une pression partielle de dioxyde de carbone supérieure à 45 mmHg. L'insuffisance respiratoire aiguë est une situation fréquente, fait partie des urgences vitales, le traitement sur les organes nobles, le cerveau, l'urètre et le myocarde.

Son diagnostic est essentiellement clinique. Il pose un problème de diagnostic étiologique, dont la nécessité de faire une démarche de diagnostic étiologique, également un problème de prise en charge thérapeutique. Sur le plan physiopathologique, il va rappeler l'étape de la respiration.

L'étape de la respiration comporte la ventilation, la diffusion, le transport du sang et les besoins sont adaptés en fonction de la commande ventilatoire. Donc l'étape de la respiration, nous avons la ventilation. C'est l'ensemble des phénomènes qui aboutissent au renouvellement de l'air alvéolaire par mobilisation de gaz respiratoire.

Donc la ventilation, besoin d'une commande centrale qui va adapter en fonction des besoins. Une afférence nerveuse, un soufflet musculosquelettal et des voies aériennes supérieures et inférieures intègres. Donc si on aura des anomalies de ventilation, si on aura une anomalie de la commande centrale, une anomalie des afférences nerveuses, une atteinte du soufflet musculosquelettal ou une atteinte des voies aériennes supérieures ou inférieures.

La deuxième étape, c'est la diffusion, c'est le transport du gaz au niveau des espaces alvéolaires, la diffusion entre les alvéoles et les capillaires. Il requiert une membrane alvéolocapillaire, une perfusion adaptée dans le territoire ventilé, également un débit cardiaque. Puis on aura le transport du gaz du sang.

Dans le cours de physiopathologie, vous avez le principal transporteur des gaz du sang, c'est l'hémoglobine. Donc le gaz, l'oxygène CO_2 va être transporté par l'hémoglobine. On aura une extraction périphérique de l'oxygène par l'échange d'eau, puis on a l'élimination de CO_2 .

Puis les mécanismes de l'insuffisance respiratoire. On a pratiquement quatre mécanismes qui

peuvent expliquer l'insuffisance respiratoire. On aura l'hypoventilation alvéolaire, l'anomalie du rapport ventilation-perfusion, chaînes sanguines droite à gauche, une perturbation de la diffusion des gaz.

Il faut rappeler que ces mécanismes peuvent être intriqués chez les mêmes sujets. Tout d'abord, l'hypoventilation alvéolaire. L'hypoventilation, c'est une définition, c'est le défaut de renouvellement du gaz alvéolaire.

Il est causé soit par une diminution de la volatilisation totale, par une diminution du volume courant, soit par une augmentation de la ventilation de l'espace mort. Cette hypoventilation alvéolaire, elle est rarement observée de façon isolée, sauf en cas de dépression des respirateurs d'origine centrale. Les idéologies de l'hypoventilation alvéolaire, sur un poumon normal, cette hypoventilation peut être centrale, pour l'affection neuromusculaire ou l'affection paritale, ou survenue sur atteinte du poumon pathologique, sur atteinte du poumon ou les voies aériennes.

Le deuxième mécanisme de l'insuffisance respiratoire aiguë, c'est l'anomalie du rapport ventilation-perfusion. Il faut rappeler qu'un sujet sain, il a pratiquement une adéquation locale de la perfusion à la ventilation. Et qu'il y a ce rapport de ventilation-perfusion, il augmente de la base vers le sommet.

L'insuffisance respiratoire aiguë est due à une mauvaise harmonisation de la ventilation au début sanguin puis monaire. Plusieurs mécanismes, dont les anomalies du rapport ventilation, vont décrire ce qu'est l'effet Schentz et l'effet espace mort. L'effet Schentz, vous avez une perfusion qui est normale, mais la ventilation est faible ou absente.

L'effet espace mort, vous avez la ventilation alvéole qui est présente, mais la perfusion pulmonaire est absente. Pour qu'il y ait de la Schentz droite à gauche, c'est le passage du sang veineux dans le système artériel, sans avoir traversé les ondes ventilées du poumon. Il faut rappeler pour différencier entre Schentz vrai et Schentz négatif, que dans le Schentz, l'hypoxémie n'est pas améliorée par l'inhalation d'oxygène pur, contrairement à l'effet Schentz.

Et l'éthiologie de la Schentz droite à gauche, c'est la communication entre le corps droit et le corps gauche, les conditions interventriculaires et interoculaires, également les fustiles artériovineuses pulmonaires. Également, parmi les mécanismes physiopathologiques de l'insuffisance respiratoire aiguë, il faut citer les troubles de la diffusion des gaz par atteinte de la membrane alvéolocaire épipélaire, qui se traduit dans le cas d'inhalation de gaz toxique, intoxication viscérale, ou au cas d'infection également par des virus. Il faut rappeler que les mécanismes physiopathologiques, qu'ils soient hypoventilation, anomalies des rapports ventilation-perfusion, Schentz gauche, droite gauche, les troubles de diffusion, ces mécanismes peuvent être intriqués.

Les conséquences de l'époxémie ou de l'insuffisance respiratoire, la déconséquence sur l'équilibre acido-basique, sur le contrôle respiratoire, la déconséquence également sur la paille cardiovasculaire, également conséquences sur d'autres systèmes, le système nerveux, le système rénal et digestif. Les conséquences de l'équilibre acido-basique, au cas des peaux ventilation alvéolaires, le rapport bicarbonate d'épaisseur d'eau inférieure à 20, le pH diminué, on aura une acidose respiratoire. Au cas des peaux ventilation alvéolaires, le bicarbonate sur l'épaisseur d'eau supérieure à 20 et le pH est augmenté sur l'alcalose respiratoire.

Également, on peut avoir du bicarbonate et du pH diminué sur l'acidose métabolique, et du bicarbonate et du pH augmenté sur l'alcalose métabolique. Sur les conséquences sur la paille respiratoire, on aura, au cas d'insuffisance respiratoire, une accélération du rythme respiratoire, on aura une polypnée. Également, une perte de réactivité au CO₂, ce qui se voit surtout au cours des poussées aiguës de l'insuffisance respiratoire chronique.

Également, des conséquences cardiovasculaires dues à l'amputation anatomique des vaisseaux de la vasoconstriction et une augmentation du volume sanguin circulant. Également, les conséquences sur les autres appareils, sur le cerveau, l'ora, le foie et le tube digestif. L'insuffisance respiratoire, vous avez des troubles de la conscience, la confusion, les troubles neuropsychiques, le coma.

Sur le rein, nous avons dit qu'au cours des époxysmes, on aura des vasoconstrictions, donc une diminution de la perfusion du rein, on aura donc oligurie. Au niveau du foie, on aura également des cytolises, une augmentation des transaminases. Également, conséquences sur le tube digestif avec des ulcères de stress, des hémorragies digestives et un ulus paralytique.

Nous avons dit que le diagnostic de l'insuffisance respiratoire est essentiellement clinique. Dans le syndrome clinique, il y a surtout des signes respiratoires, qui peuvent être des signes fonctionnels et des signes physiques. Les signes fonctionnels, c'est la dyspnée.

Quand il y a la dyspnée, soit la polypnée, bradypnée, tachypnée. Également, au cours de l'insuffisance respiratoire, il y a une difficulté de lucution, de parler. C'est un signe de cavité.

Il y a des signes de lutte, de cornage ou de stridor en cas d'obstacle. Et c'est tout la toux. L'absence de la toux, c'est un facteur de mauvais pronostic.

À l'examen physique, il faut chercher la cyanose. Il faut quantifier la fréquence respiratoire. Polypnée, tachypnée, bradypnée, vaposé.

Il faut voir si cette respiration est inspiratoire ou expiratoire. Les signes de lutte, particulièrement le tirage, le battement des yeux du nez. L'examen de l'appareil respiratoire, notamment l'auscultation.

Il faut chercher des râles, une diminution des murs musculaires. Et surtout lorsqu'on a un signe

de gravité, c'est le silence auscultatoire. Il faut chercher la respiration abdominale paradoxale.

Grâce à l'oxymétrie, on va mesurer la saturation d'oxygène. La saturation d'oxygène est inférieure à 90%. À côté des signes respiratoires de l'examen de l'appareil respiratoire, il faut rechercher les signes cardiovasculaires.

Les signes cardiovasculaires peuvent traduire le retentissement de l'insuffisance respiratoire. Ou également, les signes cardiovasculaires recherchent une cause cardio-vasculaire responsable de l'insuffisance respiratoire aiguë. On montre que les signes cardio-respiratoires peuvent avoir une tachycardie sinusale, des troubles de rythme, des bradycardies, c'est un signe de gravité.

Une vasodilatation cutanée, rougeur des pommettes, sueur et hypertension artérielle qui traduisent. Ce sont des signes cardiovasculaires qui traduisent l'hypercarbone. Également des signes d'insuffisance cardiaque droite.

Rechercher une diminution de la perfusion du vaisseau rénal. On aura une oligoanurie. On peut avoir un collapsus de reventilation.

On peut également avoir un arrêt cardio-respiratoire. À côté des signes respiratoires, des signes cardio-vasculaires, il y a des signes neurologiques qu'il faut rechercher. Ces signes neuropsychiques, peut-être neurologiques, psychiques ou des troubles de conscience.

On peut avoir, en cas d'insuffisance respiratoire aiguë, on peut rechercher l'ensemble de céphalées, de tremblements, des troubles psychiques actifs, des troubles de mémoire, des orientations temporo-spatiales et des troubles de conscience en forme de somnolence, d'obnubilation voire coma. De l'intérêt de l'évaluation neurologique en cas d'insuffisance respiratoire aiguë. Rechercher les signes de gravité.

Les signes de gravité qui justifient le recours immédiat à l'assistance ventilatoire. Vous avez une hypoxémie, une défaillance de l'appareil respiratoire. Donc, en cas de signes de gravité, ça va justifier le recours à l'assistance ventilatoire.

Ces signes de gravité précèdent de peu la récarte du respirateur. Donc, il faut agir rapidement parmi les signes de gravité qu'on peut rechercher. C'est l'incapacité totale de parler.

Les troubles sévères de la conscience évalués par le score de Glasgow en 2011 ont une oxymétrie. Saturation en oxygène inférieure à 90%. Au total, les signes d'hypoxémie, on aura des signes d'hypercapnée.

La cyanose fait partie des signes d'hypoxémie. On peut avoir les conséquences d'hypoxémie, la tachycardie, les troubles de rythme, asthénie, la confusion, la confusion et le coma. Les signes d'hypercapnée, la vasodilatation cutanée, sueur, hypertension artérielle, céphalée, asthénie et troubles neurologiques.

Au total, la cyanose est un signe d'hypoxémie. La vasodilatation cutanée, le sueur et l'hypertension artérielle sont des signes d'hypercapnée. Lorsque vous avez un mal qui est cyanosé, c'est un signe d'hypoxémie.

La cyanose, on la met au niveau de l'orbite de l'oreille, au niveau des lèvres. Vous avez des vasodilatations ou du sueur ou d'hypertension, ce sont des signes d'hypercapnée. L'hypoxémie normocapnique est moins grave que l'hypoxémie avec l'hypercapnée.

À côté des signes cliniques respiratoires, cardiovasculaires et neurologiques, il y a les anomalies biologiques. Il faut faire une gazométrie artérielle. La gazométrie artérielle va montrer l'importance de l'hypoxémie.

Elle fait le diagnostic de l'insuffisance respiratoire. Une hypoxémie inférieure à 61 mmHg fait la définition de l'insuffisance respiratoire aiguë. Lorsqu'elle est très inférieure à 60 mmHg, on aura cette hypoxémie sévère.

Sur toute la gazométrie, on cherche la variation de la pression partielle du CO₂. Lorsqu'on a la pression normale au diminué, on parle d'hyperventilation alvéolaire. Lorsque la pression partielle du CO₂ est supérieure à 45 mmHg, c'est l'hypercapnée.

L'hypoxémie avec l'hypercapnée traduit l'hyperventilation alvéolaire. L'hyperventilation alvéolaire est très grave par rapport à l'hyperventilation alvéolaire lorsque vous avez le PCO₂ normal au diminué. L'intérêt de l'analyse de la gazométrie, c'est d'analyser la PO₂ pour diagnostiquer l'insuffisance respiratoire et le PCO₂ pour les signes de gravité.

Lorsqu'on cherche l'hypercapnée, lorsqu'on a une hypercapnée, elle va traduire l'hyperventilation alvéolaire. Également, l'ionogramme sanguin à la recherche d'hypochlorémie, l'hypercalémie en présence d'une acidose, l'hémogramme à la recherche d'une anémie ou d'une polyglobuline et le bilan hépatique. Nous avons dit que parmi les conséquences de l'insuffisance, on a commencé sur le fond en recherche des cytolyses hépatiques par dosage de transaminase.

Le diagnostic est essentiellement clinique. Il est très facile, mais le problème qu'il pose, c'est un problème diagnostique et thérapeutique. Les éléments diagnostiques sont l'interrogatoire, l'âge du patient, les antécédents personnels, les facteurs déclenchants, les circonstances de survenue de l'insuffisance respiratoire et surtout l'examen clinique.

On va examiner l'appareil respiratoire, l'appareil cardiovasculaire et l'examen général. Cet examen doit être rapidement possible tout en mettant en place les mesures de réanimation. Pour l'interrogatoire, on va rechercher les circonstances de survenue, le cas de traumatisme, l'éthiologie évidente, le cas de noyade, l'éthiologie de la cause de l'insuffisance respiratoire est évidente également.

On va rechercher le mode de début, qui peut être brutal ou progressif. Cette insuffisance est

associée à d'autres signes respiratoires ou extra-respiratoires. Est-ce qu'il y a, dans le sens de l'épisode antérieur, par exemple l'asthmatique ? C'est-à-dire que l'asthmatique vient d'un tableau d'insuffisance respiratoire.

Il faut penser à l'asthme grave, l'existence d'une insuffisance respiratoire chronique, le mal sur l'oxygène de thérapie à longue durée. Ça peut être une poussée aiguë d'une insuffisance respiratoire chronique. On va rechercher les pathologies associées, la cardiopathie, la néphropathie, le diabète.

Est-ce qu'il y a des traitements suivis ? Est-ce qu'il y a des traitements médicamenteux ? Les abus toxiques, le tabac, l'alcool, la toxicomanie, et les activités professionnelles actuelles ou antérieures. Donc l'intégratoire est très important. Il est un élément d'orientation vers l'étiologie responsable aux causes de l'insuffisance respiratoire aiguë.

L'examen, au cas d'insuffisance respiratoire, on va dire qu'il est un examen de l'appareil respiratoire. L'examen cardio-vasculaire, c'est un examen général. L'examen de l'appareil respiratoire, il peut être normal.

Il peut être évident des signes d'obstacles au niveau des voies aériennes supérieures. Il peut montrer un syndrome de penchement pleural ou aérien. Il peut montrer un syndrome de condensation des branches humérales ou des râles bronchiques.

Si on a une maladie bronchique, asthme ou BPCO. L'examen cardio-vasculaire, on va chercher des perturbateurs artériels, troubles de rythme. Ce sont des conséquences de l'hypoxémie ou de l'hypocapnée.

L'examen cardiologique, c'est des signes d'insuffisance cardiaque gauche. L'examen général, c'est surtout la recherche des signes de thrombophylie avec des signes de hémolyse. C'est une douleur à la dorsiflexion, traduit de thrombose veineuse profonde des membres inférieurs.

On cherche des signes neurologiques. On cherche également l'obésité. Pour les examens paracliniques, tout d'abord une gazométrie artérielle va mesurer la pression partielle d'oxygène, la pression partielle de CO₂, le pH, le taux de bicarbonate et la saturation d'oxygène.

Également les éléments d'orientation, c'est la radiographie thoracique, le CG et les coquilles radiographiques en origine cardiaque de l'insuffisance respiratoire. Et d'autres examens qui vont orienter vers certaines pathologies. Lorsqu'on demande l'aide immédiate, lorsqu'on suspecte une embolie pulmonaire, donc une cause cardiovasculaire de l'insuffisance respiratoire.

Le problème P, c'est pour discriminer entre une origine pulmonaire ou cardiaque de l'insuffisance respiratoire. C'est un examen très très important. L'hémogramme, recherche d'une polycythémie neutropénie, qui est un facteur de gravité de la pneumonie.

Rechercher une polyglobulie, au cas d'insuffisance respiratoire chronique. Un bilan

inflammatoire, la CRP, la procalcitonine. Recherche de BK.

Donc nous sommes dans trois situations. La radiographie thoracique peut être normale. Si on a un tableau d'insuffisance respiratoire aiguë avec radiographie normale, il faut penser à une atteinte neurologique, à l'atteinte de la commande.

Si vous avez une radiographie thoracique, vous avez des clartés. Des clartés, c'est peut-être un pneumothorax, une origine pleurale de l'insuffisance respiratoire aiguë, du bulldonfysème, un corps étranger, de la BPCO. On ne peut pas citer qu'il y a peut-être un alvéolaire interstitiel.

L'alvéolaire, c'est la pneumonie, le OAP. Interstitiel, le pneumopathie, l'infiltrant diffuse. En bandes, donc adenbolies, pleurales et motoraxes.

On a un mot fracturé de code. Donc la radiographie thoracique est un élément important dans le diagnostic étiologique de l'insuffisance respiratoire aiguë. Soit il va être normal, on va penser à une atteinte neurologique, soit on va montrer des atteintes qui évoquent une atteinte par enchamateuse, ou atteinte pleurale, ou paritale en cas de fracture de code.

Pour les étiologies, il y aura l'insuffisance respiratoire de cause neurologique, par atteinte des centres respiratoires, des commandes, en cas d'accident vasculaire cérébral, en cas d'intoxication oséo, en cas de médicaments qui dépriment les centres respiratoires, en cas d'acidose métabolique, dans le cas du crâne optabolique, en cas de diabète. On peut avoir une atteinte modulaire, une polyradiocolonivrite, une atteinte de l'injection neuromusculaire en cas de myasthenie, paralysie et diaphragmatique. Donc l'insuffisance de cause neurologique, la radiographie thoracique, elle est normale.

On a également l'insuffisance respiratoire par obstruction des voies aériennes. Les voies aériennes supérieures et inférieures. Pour les voies aériennes supérieures, les éléments d'orientation, c'est la discipline inspiratoire, c'est le cornage, c'est le stridor, les bruits anormaux.

On va rechercher le dème de Koink, un corps étranger, des tumeurs, des compressions extrinsèques. Donc l'insuffisance respiratoire par obstruction des voies aériennes supérieures, c'est sous la discipline inspiratoire. Les bruits anormaux, ce sont le cornage et le stridor.

L'insuffisance par obstruction des voies aériennes distales, donc les principaux diagnostics, c'est l'asthme grave et la décompensation de BPCO. L'asthme grave, vous avez une fréquence respiratoire de 35 par minute, cyanose, entopnée, difficulté de parler, des signes de lutte, la fréquence cardiaque à la supération 10, anxiété, agitation, surtout silence auscultatoire. Vous avez un débit de pointe qui est inférieur à 33%.

Également parmi les étylogies de l'atteinte des voies aériennes, décompensation de BPCO, c'est quelqu'un qui a tabagé avec BPCO, et le facteur de cette insuffisance respiratoire, c'est la prise midi-décrementeuse, l'habit d'oxygène, le sévrage, le corticoïd. Les signes de gravité, c'est la

cyanose, l'agitation, la respiration et l'acidose respiratoire. L'insuffisance par obstruction de voies aériennes distales, pensez à l'asthme grave et la décompensation de BPCO.

Également, insuffisance respiratoire par atteinte cardiovasculaire. On nous dit que les atteintes cardiovasculaires peuvent être conséquences de l'insuffisance respiratoire, peut-être la cause, parmi les causes cardiovasculaires de l'insuffisance, c'est le EDM aigu du poumon et l'embolie pulmonaire. Dans l'EDM du poumon, on aura l'EDM cardiogénique et l'EDM lésionnelle.

Pour l'EDM cardiogénique, c'est le plus fréquent. L'insuffisance ventriculaire gauche, le diagnostic est facile, on aura des râles crépitants bilatéraux et à la radiographie, des images en ailes de papillon. L'EDM lésionnelle est due à l'altération de la membrane alvéocapillaire, la forme typique, c'est le syndrome de détresse respiratoire.

Pour les causes vasculaires, on a l'embolie pulmonaire, il faut chercher les facteurs de risque, c'est-à-dire l'alignement, et rechercher les signes de thrombofilie, et le diagnostic par les D-dimères et par l'angioscanner. Donc, les étiologies cardiovasculaires de l'insuffisance respiratoire, vous avez l'EDM aigu du poumon, et l'embolie pulmonaire. Également, on peut avoir l'insuffisance respiratoire aiguë par atteinte par enchevêtrement, en cas de pneumonie, et en cas de grippe maligne, et en cas d'hémorragie alvéolaire, intra-alvéolaire.

Mais on va parler surtout de la pneumonie, qui peut être communautaire, nosocomiale. Aux pneumonistes, nous venons sur un immunodéprimé. Également, la grippe maligne peut être responsable d'insuffisance respiratoire aiguë, mais qui survient dans un cas de pandémie.

Et l'hémorragie intra-alvéolaire, on aura une insuffisance respiratoire avec hémoptysie et anémie. Et le diagnostic se fait à la fibroscopie avec lavage bronchoalvéolaire, par la recherche du siderophage. Également, parmi les étiologies de l'insuffisance respiratoire, on a l'insuffisance respiratoire par atteinte du soufflet thoracomuscle pleura.

C'est atteinte du traumatisme thoracique, fracture du côtes, pneumothorax, rupture diaphragmatique. En dehors d'un traumatisme, c'est la grippe pneumothorax spontanée, en cas de pleurésie, grande abondance d'installation rapide. Pour ce qui est du traitement, le but du traitement, c'est assurer la liberté de voie aérienne, assurer une ventilation efficace, et assurer un apport suffisant d'oxygène.

Les moyens se divisent en traitement symptomatique, et bien sûr, traitement de l'étiologie. Le traitement symptomatique, soit la libération de voie aérienne par la toux, par le drainage pleural, par les aspirations trachéales, ou l'oxygénothérapie. Les moyens, on utilise des centres nasaux, des lunettes, des masques, des centres d'intubation.

Adapter les débuts pour que la saturation dépasse 90 %, sont l'acidose métabolique. Également, on aura le terme, c'est l'assistance ventilatoire, par une ventilation mécanique, non invasive, qu'on appelle la VNI, et l'indication, en cas de trouble de conscience, ou en cas d'acidose

ventilatoire sévère, ou en cas d'état de choc. Sans oublier, à côté du traitement symptomatique ou du traitement étiologique, ce qui doit être le plus précoce possible, si vous avez une infection sur l'antibiothérapie, si vous avez un pleurothorax, une pleurysie sur le drainage, si vous avez un corps étranger, l'extraction du corps étranger, si vous avez une embolie, c'est les anticoagulants, le cadasse, le bronchospasme, vous avez les bronchodilatateurs.

Synthèse. Devant des tableaux d'insuffisance respiratoire, il faut chercher des signes de gravité. Mesurer la saturation de l'oxygène, s'il est inférieur à 90 % ou 8, le traitement symptomatique immédiat, soit une oxygénothérapie par masque, lunettes ou son, nasal, ou une ventilation assistée.

S'il n'y a pas de signe de gravité, il faut faire une enquête étiologique. On va voir que soit le diagnostic est évident, par exemple le traumatisme, la noyade, l'hémoptysie, soit le diagnostic est simple, l'asthme ou l'apaisement pleural, l'essoufflement poussé d'insuffisance respiratoire, ou lorsque le diagnostic n'est incertain, on doit faire une radiographie thoracique. Selon les données de la radiographie thoracique, on a des types d'anomalies qui vont orienter vers tel ou tel diagnostic d'insuffisance respiratoire.

Si on a une pathologie pleurale, soit le pneumothorax ou une pleurysie, soit une pathologie par enchymateuse, peut-être alvéolaire, interstielle ou atelectasique. En cas de pathologie alvéolaire, peut-être symétrique ou asymétrique. Lorsqu'il est asymétrique, on pense à une pneumopathie infectieuse.

Lorsqu'il est symétrique, à OAP, hémorragie alvéolaire, cancer et alvéolite allergique extrinsèque. En conclusion, l'insuffisance respiratoire est une situation fréquente. Son diagnostic est essentiellement clinique.

C'est une urgence qui nécessite un traitement immédiat. Il pose un problème surtout du diagnostic étiologique. Message, il ne faut pas se contenter de traiter la défaillance respiratoire, mais il faut rechercher le facteur responsable de son traitement pour éviter la récurrence.

Merci de votre attention.